

Sacrocolpopexia

Información para el paciente · Una elevación duradera, con malla, para el prolapso del fondo de la vagina

WARWIKI

La sacrocolpopexia es una de las reparaciones más duraderas para el prolapso del **fondo de la vagina o del útero** (el ápice). Se usa una malla suave para elevar el fondo de la vagina y fijarlo a un ligamento fuerte sobre el coxis (el sacro), restaurando la posición y la profundidad naturales. Suele hacerse con cirugía por ojo de cerradura (robótica o laparoscópica) y conserva la capacidad de tener relaciones sexuales.

Acerca de este procedimiento

Se fija una **malla** a la parte delantera y trasera del fondo de la vagina y luego se sujeta al ligamento firme sobre el **sacro**. Esto mantiene la vagina elevada en su posición normal. Se considera la reparación de **referencia** para el prolapso apical por su gran durabilidad.

Acerca de la malla

La malla que se usa aquí se coloca a través del **abdomen** y tiene un historial de seguridad sólido y bien estudiado. Es **diferente** de la malla transvaginal (a través de la vagina) para el prolapso que fue objeto de advertencias de la FDA y se retiró del mercado. Su cirujano hablará de los pequeños riesgos, incluida una rara posibilidad de exposición de la malla.

APRENDA LOS TÉRMINOS

Ápice / cúpula

El fondo de la vagina, que puede descender tras el parto o una histerectomía.

Sacro

El hueso en la base de la columna; su ligamento ancla la reparación.

Malla

Un material suave y permanente que sostiene el fondo de la vagina.

Robótica / laparoscópica

Cirugía por ojo de cerradura con unas pocas incisiones pequeñas.

Exposición de la malla

Un problema poco común en que una parte de la malla queda visible; tratable.

Histerectomía

Extirpación del útero, a veces hecha al mismo tiempo.

¿LE DOLERÁ? Se hace con anestesia general, así que no siente nada durante la cirugía. Con la cirugía por ojo de cerradura, la mayoría tiene molestias leves en las incisiones pequeñas y algo de gas, y vuelve a casa el mismo día o tras una noche. La cirugía más amplia o abierta requiere algo más de recuperación.

Cómo prepararse

- Se hace con **anestesia general** — siga las indicaciones de ayuno y medicamentos (suspenda los anticoagulantes según le indiquen).
- Una evaluación preoperatoria; puede combinarse con una **histerectomía** o un procedimiento para la incontinencia.
- No fume; organice quién lo lleve y ayuda en casa.

Qué sucede

- 1 Usted está dormido; se administran antibióticos.
- 2 Por incisiones de ojo de cerradura (o una abierta), se fija la malla al fondo de la vagina.
- 3 La malla se sujeta al ligamento del sacro, elevando la vagina a su sitio.
- 4 Se coloca una sonda por poco tiempo.

Después de la cirugía

- A casa el mismo día o tras una noche; actividad ligera al principio.
- **Evite levantar peso, hacer esfuerzo y tener relaciones sexuales unas 6 semanas.**
- Es normal un poco de manchado y molestia leve; trate el estreñimiento.

Llame a su equipo si tiene:

- Fiebre o escalofríos
- Sangrado abundante, o dolor abdominal o pélvico que empeora
- **No puede orinar**, o náuseas/vómitos persistentes
- Flujo vaginal con olor, o dolor con las relaciones más adelante (posible problema de la malla)

TRES COSAS PARA RECORDAR

1. La sacrocolpopexia eleva el fondo de la vagina con malla anclada al sacro — la reparación más duradera para el prolapso apical, suele ser por ojo de cerradura.
2. Su malla abdominal está bien estudiada y es distinta de la malla transvaginal de prolapso retirada del mercado.
3. Evite levantar peso y las relaciones unas 6 semanas. Llame si tiene fiebre, sangrado abundante, no puede orinar, u olor/dolor más adelante.